

La constipation

Dr. N. IDRI

Objectifs pédagogique :

- Définir une constipation
- Savoir faire une démarche diagnostique d'une constipation
- Reconnaître les étiologies de la constipation

Plan :

- Définition
- Physiopathologie
- Etude sémiologique
- Examens complémentaires
- Etiologies

La constipation

Dr. N. IDRI

I. Définition :

- La constipation chronique est un syndrome très fréquent mais qui reste difficile à définir.
- Sur le plan clinique, la constipation se définit par un nombre de selles inférieur à 3 par semaine avec un poids moyen quotidien des selles inférieur à 35 g.
- **Les critères de Rome IV** constituent une définition plus précise et plus moderne : au moins 2 des symptômes suivants depuis au moins 6 mois :
 - Moins de 3 selles spontanées par semaine
 - Effort de poussée lors des défécations
 - Selles dures (B1-B2 selon l'échelle de Bristol)
 - Sensation d'évacuation rectale incomplète
 - Manœuvres d'évacuations : s'aider pour évacuer les selles grâce à : une pression abdominale, une pression fessière, une manœuvre périnéale (masser autour de l'anus), des digitations endo-vaginales (en appuyant sur la face postérieure) ou endo-anales.

II. Physiopathologie :

- Une défécation normale se décompose en 3 temps :
 - Stagnation des matières dans le sigmoïde
 - Progression des selles du sigmoïde vers le rectum qui déclenche le réflexe recto-anal inhibiteur
 - défécation par perception du besoin du canal anal, contraction des muscles de l'abdomen et une poussée des muscles releveurs de l'anus
- On distingue deux types de constipation :
 - 1- Constipation maladie : la plus fréquente, souvent ancienne et isolée, deux mécanismes physiopathologiques prédominant mais peuvent être associés :
 - Un trouble de la progression sur l'ensemble du côlon par inhibition de la motricité globale
 - Un trouble de l'évacuation ou dyschésie.
 - 2- Constipation symptôme : il s'agit souvent d'une constipation plus ou moins récente, secondaire, relevant ou accompagnant d'autres processus pathologiques.

III. Etude sémiologique :

A. L'interrogatoire : est un élément capital devant préciser :

1. Les antécédents personnels notamment chirurgicaux : chirurgie proctologique, urinaire, gynécologique, ou digestive

2. Le caractère de selles : fréquence, irrégularité des défécations, l'aspect des selles : volumineuses (bouchon), petites en forme de billes (on utilise l'échelle de Bristol pour aider le patient à décrire ses selles).
3. Le mode de début et évolution :
 - Récente et transitoire : à l'occasion d'un changement de rythme de vie ou professionnel
 - Récente et persistante : cause organique et en particulier un cancer colorectal
 - Ancienne et chronique, évoquant plutôt une cause motrice ou fonctionnelle.
4. Existence de manœuvres digitales pour faciliter l'exonération et la défécation, évocatrices d'une dyschésie anorectale (stagnation des matières fécales dans le sigmoïde par troubles de la l'évacuation).
5. existence de facteurs déclenchant : prise de nouveaux médicaments, modification des habitudes alimentaires avec diminution des apports hydriques et en fibres non digestibles, alitement.
6. Symptômes associés : douleurs abdominales, vomissements, météorisme, évacuation anormale : sang, glaire ; retentissement sur l'état général.
7. Traitement suivi notamment la nature des laxatifs utilisés.

B. L'examen physique :

1. L'examen abdominal : comporte l'inspection, la percussion et la palpation et l'auscultation : à la recherche d'une distension, un tympanisme, une hernie ou une éventration, une masse tumorale, une augmentation des bruits hydroaériques (obstacle).
2. L'examen de la région anorectale et périnéale est une étape importante :
 - L'examen doit être fait en position accroupie lors de la poussée pour chercher un prolapsus rectal ou une ballonnisation périnéale.
 - L'examen en position genu-pectorale cherchera une lésion anale à type de fissure, hémorroïdes, tumeur ou abcès.
3. Le toucher rectal :
 - Apprécie la tonicité du sphincter anal
 - Recherche : une sténose anale ou rectale, une contracture paradoxale du sphincter anal (anism), ampoule rectale vide, l'existence de matière chez un malade qui n'éprouve pas le besoin d'aller à la selle, ce qui permet d'évoquer le diagnostic de dyschésie rectale, un rectocèle.
4. Le toucher vaginal : chez la femme, recherche des lésions gynécologiques pouvant occasionner une constipation.
5. Le reste de l'examen physique doit être complet à la recherche d'une pathologie associée à l'origine de la constipation.

IV. Examens complémentaires :

A. Bilan initial : visant à éliminer une cause organique :

- Anuscopie, rectoscopie, coloscopie, coloscanner ou lavement baryté
- Un bilan biologique peut être demandé notamment le dosage des hormones thyroïdiennes si une hypothyroïdie est suspectée.

2. Bilan de 2^{ème} intention : est demandé en fonction du contexte clinique, notamment si une constipation fonctionnelle est suspectée, il comprend essentiellement

- la mesure du temps de transit colique :
- une défécographie
- une manométrie anorectale.

V. ETIOLOGIES :

A. Constipation organique :

1. Causes digestives : Cancer colorectal, tumeurs bénignes colorectales, sténoses coliques ou anorectale, mégacôlon congénital, fissure, séquelles de chirurgie anorectale, compressions extrinsèques.

2. Causes endocriniennes et métaboliques : hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, insuffisance rénale, hypokaliémie, porphyrie.

3. Causes neurologiques et constipation psychogène : dysautonomie au cours du diabète et de l'amylose, maladie de parkinson, sclérose en plaque, accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale, dépression, démence et psychose.

4. Médicaments : opiacés, anticholinergiques, anti convulsivants, neuroleptiques...

B. Constipation maladie :

1. Par anomalie de progression :

-Dans ce cas : souvent le nombre de selles < 3 par semaine, ballonnement abdominal, douleur abdominale, pas de besoin entre les exonérations, selles dures.

-Les causes : Inertie colique, colon spastique

2. Par anomalie d'évacuation :

- Souvent le besoin est présent, difficulté d'exonération, au TR : matières présentes, souvent utilisation de manœuvre digital pour évacuer.

- Les causes : anisme , méga rectum , rectocèle, procidence interne du rectum, anomalie de la sensibilité rectale, plancher pelvien descendant.

Référence :

-Evelyne Moulin, Pour en finir avec la constipation, e-book, Ed. Les Asclépiades, 2014

-Higgins PD, Johanson JF, Epidemiology of constipation in North America: a systematic review [archive], Am J Gastroenterol, 2004;99:750-9

-Brian E. Lacy, Fermín Mearin, Lin Chang et William D. Chey, « Bowel Disorders », *Gastroenterology*, série Rome IV - Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction, vol. 150, n° 6, 1^{er} mai 2016, p. 1393–1407.e5 (DOI 10.1053/j.gastro.2016.02.031, lire en ligne)